Gestione del paziente con scabbia sospetta o conclamata in ambiente ospedaliero

Redazione	Verifica di processo	Verifica metodologica	Approvazione
Redattore per il gruppo SOSD Infezioni Correlate all'Assistenza Emanuela Spadini	Responsabile del processo/attività Direttore SOSD Infezioni Correlate all'Assistenza Anna Patrizia Poli	Direttore SOSD Programmazione e monitoraggio documentazione sanitaria Marco Brogi	Direttore Sanitario Simona Dei Direttore Area Qualità e Sicurezza delle cure Raffaella Giannini

Gruppo di redazione

- Giovanna Arlotto, Assistente Sanitario, SOSD Attività di Assistenza Sanitaria di Firenze.
- Elisa Bonchi, Assistente Sanitario, SOSD Attività di Assistenza Sanitaria Firenze.
- Enrica Lacerenza, Infermiera, Rischio Infettivo SOS Assistenza Infermieristica ed Ostetrica Prato.
- Federico Mannocci, Medico Igienista, DSPO Prato.
- Giuditta Niccolai, Medico Igienista, Direttore Sanitario DMPO Pescia.
- Luigi Pisano, Medico Dermatologo, SOC Dermatologia I/II, Firenze.
- Anna Patrizia Poli, Medico Igienista, Direttore SOSD Infezioni Correlate all'Assistenza.
- Emanuela Spadini, Infermiera, SOSD Infezioni Correlate all'Assistenza.
- Paola Zini, Medico Igienista, UFC Igiene Pubblica e Nutrizione Firenze.

Supporto metodologico:

- SOSD Programmazione e monitoraggio documentazione sanitaria

Parole chiave: scabbia, paziente, contatti, terapia.

Copia non valida come originale

Indice

1. Premessa 2
2. Scopo/ Obiettivi 2
3. Riferimenti 3
4. Campo di applicazione e destinatari 3
5. Glossario e acronimi 3
6. Responsabilità e descrizione delle attività 4
7. Definizione 5
8. Ciclo biologico del parassita 5
9. Epidemiologia della trasmissione 5
10. Clinica 5
11. Forme particolari di scabbia 6
12. Diagnosi 7
13. Trattamento della scabbia 7
14. Notifica e sorveglianza sanitaria 8
15. Identificazione e gestione del caso sospetto di scabbia in ambito ospedaliero 9
16. Gestione del paziente nei setting di degenza 11
17. Diffusione/Conservazione/Consultazione/Archiviazione 11
18. Monitoraggio e controllo 11
19. Revisione 11
20. Swim lane 12
21. Allegati 12
22. Indice revisioni 12
23. Lista di diffusione 13

1. Premessa

La scabbia è una delle condizioni dermatologiche più comuni e rappresenta una parte sostanziale delle malattie dermatologiche nei Paesi in via di sviluppo.
È una malattia infettiva contagiosa della cute che si trasmette da persona a persona per contatto diretto prolungato che indiretto.
La scabbia è una ectoparassitosi a trasmissione interumana causata da Sarcoptes scabiei var. hominis, acaro parassita obbligato che ha il suo intero ciclo di vita nella pelle umana.
Nei Paesi ad alto reddito i casi sono sporadici ma sono presenti talvolta focolai nelle strutture sanitarie ed in comunità vulnerabili che rappresentano un costo significativo nei servizi sanitari nazionali.
La malattia può colpire chiunque, in ogni fascia di età, senza distinzione di sesso, etnia, livello sociale o di igiene.
Più spesso sono interessati giovani adulti o anziani allettati, l'immunodepressione ne aggrava il decorso.

2. Scopo/ Obiettivi

Scopo della procedura è quello di definire le modalità operative da attuare in ambiente sanitario in presenza di sospetta malattia infettiva, scabbia, al fine di prevenire la diffusione di nuovi casi mediante la corretta individuazione, isolamento e trattamento dei soggetti colpiti e dei contatti suscettibili:

- Standardizzare percorsi e comportamenti omogenei nella gestione del paziente con scabbia.
- Diffondere gli aggiornamenti relativi alle raccomandazioni in tema di controllo e sorveglianza.
- Uniformare la gestione dei casi di scabbia tra i pazienti, operatori e contatti dei casi accertati.

Copia conforme all'originale

3. Riferimenti

BIBLIOGRAFIA:

1. WHO Fact sheet details: Scabies, last updated 31/05/23. Available at: *https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/scabies*.
2. WHO informal consultation on a framework for scabies control, World Health Organization Regional Office for the Western Pacific, Manila, Philippines, 19–21 February 2019: meeting report. Geneva: World Health Organization; 2020.
3. Centers for Disease Control and prevention. CDC Scabies Frequently Asked Questions (FAQ).
   Available at CDC Scabies FAQ.
4. *Chante Karimkhani, Danny V Colombara, Aaron M Drucker, Scott A. Norton, Roderick Hay, Daniel Engelman, Andrew Steer, Margot Whitfeld, Mohsen Naghavi, Robert P. Dellavalle* The global burden of scabies: a cross-sectional analysis from the Global Burden of Disease Study 2015, LANCET 20 settembre 2017.
5. Circolare Ministero della Sanità n. 4 del 13 marzo 1998 protocollo 400.3/26/1189 MISURE DI PROFILASSI PER ESIGENZE DI SANITA'PUBBLICA.
   Provvedimenti da adottare nei confronti di soggetti affetti da alcune malattie infettive e nei confronti dei loro conviventi e contatti.
6. Decreto 7 marzo 2022 "Revisione del sistema di segnalazione e delle malattie infettive".

RISORSE UTILI:

- Istituto Superiore di Sanità, Malattie Infettive: Scabbia, *https://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioSchedeMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=210&area=Malattie%20infettive&menu=indiceAZ*
- Recognizing neglected tropical diseases through changes on the skin: a training guide for front-line health workers. Geneva: World Health Organization; 2018. *https://apps.who.int/iris/handle/10665/272723*
- International Alliance for the Control of Scabies (IACS): *https://www.controlscabies.org*
- *https://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioSchedeMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=210&area=Malattie%20infettive&menu=indiceAZ&tab=6*
- *https://www.cdc.gov/scabies/hcp/clinical-overview/index.html#cdc_generic_section_3-prevention*

4. Campo di applicazione e destinatari

Il documento si applica a tutti i casi sospetti o accertati di scabbia nei pazienti e a tutti gli operatori sanitari e tecnici aziendali operanti all'interno dei Presidi Ospedalieri e Strutture Territoriali e del Dipartimento della Prevenzione.

5. Glossario e acronimi

CASO PROBABILE: Presenza di sintomi clinici compatibili, accompagnati o meno da esposizione documentata a contagio.
CASO CONFERMATO: Riscontro al microscopio dell'acaro, delle uova o delle feci nei cunicoli oppure da un quadro clinico tipico con riscontro della lesione patognomonica.
CONTATTO: Pazienti che hanno condiviso gli spazi per tempi prolungati con il caso di scabbia (ad esempio conviventi) o operatori che hanno prestato assistenza diretta al paziente con contatti cutanei stretti e frequenti oppure con manipolazione di biancheria sanitaria o personale del paziente.
CONTATTO AD ALTO RISCHIO: Conviventi, partner sessuali, coloro che hanno frequenti contatti cutanei con il caso indice.
CONTATTI A BASSO RISCHIO: Coloro che hanno contatti indiretti attraverso oggetti o materiali che sono stati a contatto con un caso.
A causa della labilità dell'acaro al di fuori dell'ospite, il contagio indiretto si verifica solo se questi effetti sono stati contaminati da poco tempo.

Copia conforme all'originale

La contagiosità si riduce progressivamente nel corso della terapia (24 h da inizio trattamento).
SCABBIA MISCONOSCIUTA O INCOGNITA: Caratterizzata dalla modestia del prurito e delle manifestazioni cutanee, per uso prolungato di steroidi, incapacità di riferire la sintomatologia o igiene eccessiva.
SCABBIA CROSTOSA O NORVEGESE: Presenza di lesioni crostose ricche di acari, in genere alle mani e ai piedi, tipica di persone immunodepresse, defedati o ipoevoluti.
SCABBIA NODULARE: Presenza di lesioni nodulari intensamente pruriginose, localizzate alle ascelle, genitali, glutei, piedi. Le lesioni sono disabitate dall'acaro ma il prurito può persistere per mesi.

6. Responsabilità e descrizione delle attività

FASI OPERATIVE	FUNZIONI RESPONSABILI								
	Infermiere Triage	Medico PS	Coordinatore/Infermiere PS	Medico Degenza	Infermiere Degenza	Dermatologo	IPN territoriale	DSPO	Medico Prevenzione
Compilazione della check list fattori di rischio per scabbia	**R**	I	C						
Predisposizione di isolamento funzionale in PS	C	I	**R**						
Compilazione scheda notifica malattia infettiva		**R**	C					I	
Conferma sospetto diagnostico						**R**			
Identificazione e segnalazione dei contatti stretti	C	C	**R**				I		I
Consegna opuscolo informativo per la gestione domiciliare			**R**						
Esecuzione inchiesta epidemiologica e sorveglianza sanitaria sui contatti stretti non ricoverati							**R**		
Sorveglianza sanitaria sul personale dipendente									**R**
Predisposizione di isolamento funzionale in setting degenza				C	**R**				
Consegna opuscolo informativo per la gestione domiciliare				C	**R**				
Monitoraggio della procedura								**R**	

Legenda:
R = Responsabile **C** = Collabora **I** = Informato

Copia conforme all'originale

7. Definizione

La scabbia si caratterizza per l'alta contagiosità, il prurito intenso (maggiormente notturno) e la presenza di lesioni cutanee patognomoniche (cunicolo e vescicola perlacea).

8. Ciclo biologico del parassita

L' acaro adulto è munito di 4 paia di zampe ed è in grado di muoversi sulla superficie cutanea abbastanza velocemente, potendo coprire una distanza di 2,5 cm al minuto.
La femmina adulta scava sulla superficie cutanea un cunicolo provvisorio all'interno del quale può accoppiarsi con un maschio errante, che in genere muore poco dopo l'accoppiamento.
Una volta fecondata, la femmina riemerge e inizia a scavare un cunicolo permanente dove generalmente rimane per il resto della propria vita, da 4 a 6 settimane, e dove depone ogni giorno da 2 a 3 uova, fino ad un totale di 50 - 60 uova nell'arco della sua vita.
Le uova si schiudono in 3 – 4 giorni, lasciando fuoriuscire delle larve estremamente mobili che si diffondono sulla superficie cutanea, mutando prima in ninfe (3 - 4 gg.) e poi in acari adulti (10 - 18 gg.).

9. Epidemiologia della trasmissione

La scabbia colpisce globalmente da 200 a 300 milioni di persone ogni anno, con una notevole variazione della prevalenza, che oscilla tra lo 0,2% e il 71,4% nelle diverse aree del globo.
Negli ultimi 20 anni la frequenza della patologia, sotto forma di epidemie, sembra essere in aumento e questo accade non solo nei Paesi dove la scabbia è maggiormente diffusa, ma anche in numerosi Stati storicamente caratterizzati da una bassa incidenza di malattia.
In diversi Paesi europei come Turchia, Spagna, Irlanda e anche Italia, l'aumento della trasmissione della scabbia e delle altre malattie a trasmissione sessuale non si è arrestato neppure durante la pandemia da COVID-19.
Il periodo di incubazione della scabbia dura mediamente 4 – 6 settimane nel caso di una prima infestazione; i sintomi insorgono molto più rapidamente (1 – 4 giorni) nel caso di successive re infestazioni.
La trasmissione avviene prevalentemente attraverso contatti interumani stretti e prolungati (della durata di almeno 5 - 10 minuti), spesso contatti di natura sessuale, ma non esclusivamente; più raramente la trasmissione può avvenire anche per via indiretta attraverso condivisione di biancheria da letto, vestiti e altri tessuti venuti a contatto con la cute degli ospiti infestati.
Il tempo di sopravvivenza degli acari del genere Sarcoptes al di fuori della cute umana è di pochi giorni, comunque non oltre una settimana.

10. Clinica

Le lesioni si localizzano prevalentemente alle mani (spazi interdigitali, superfici laterali delle dita, palmo, regione volare dei polsi), ai pilastri delle ascelle e alle areole mammarie, alla regione ombelicale e ai glutei.
Nel maschio è possibile il coinvolgimento dei genitali esterni (asta del pene e scroto); nei bambini della pianta dei piedi e più raramente del volto e del cuoio capelluto. (**Fig.1**).

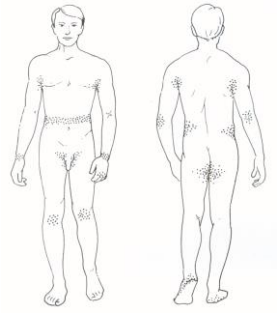


Fig. 1

Copia conforme all'originale

Le lesioni patognomoniche comprendono il cunicolo, piccolo rilievo di pochi mm con aspetto a cordoncino, di colore grigio-brunastro, dritto o più spesso tortuoso (a virgola), e la vescicola perlacea, piccolo rilievo cupoliforme, lucido e teso, a contenuto inizialmente limpido e successivamente purulento che si trova tipicamente all'estremità di un cunicolo.
Nella malattia conclamata sono spesso presenti lesioni secondarie al grattamento (escoriazioni lineari, croste ematiche) e/o alla risposta immunitaria dell'ospite (papule e noduli) (**Fig.2**).
Come complicanza del grattamento si possono avere sovra infezioni cutanee batteriche (soprattutto da Staphilococcus aureus e Streptococcus pyogenes).
La parassitosi si caratterizza per un prurito intenso, specie notturno, dovuto sia all'azione meccanica dell'acaro, sia alla risposta immunitaria dell'ospite nei riguardi dell'acaro e dei suoi antigeni (escrementi, parti di acari morti, uova ecc.).

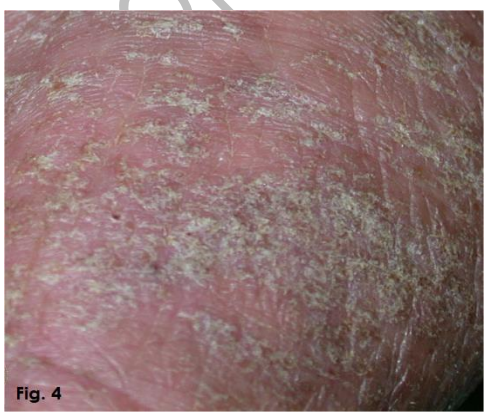

Fig. 2

11. Forme particolari di scabbia

1) SCABBIA NODULARE
In soggetti con intensa risposta immunitaria si ha dopo circa un mese dalla infestazione la comparsa di noduli persistenti, tipici della scabbia nodulare, forma poco contagiosa (**Fig.3**).


Fig. 3

2) SCABBIA NORVEGESE
Invece in soggetti anziani, immunodepressi, con disturbi neurologici o mentali ecc., nei quali la risposta dell'ospite è quasi assente e l'acaro può moltiplicarsi con grande libertà, si può avere il quadro della cosiddetta **scabbia norvegese o crostosa** con vaste aree eritematose con squamo-croste grigiastre che possono coprire anche tutta la superficie cutanea (quadri simil-eritrodermici).
La distribuzione delle lesioni di scabbia norvegese è frequentemente atipica con interessamento, oltre che delle regioni palmari, delle piante, del volto e del cuoio capelluto (**Fig. 4 e 5**).
In questa forma il prurito è scarso o può essere addirittura assente.


Fig. 4

A differenza della scabbia comune, gli acari sono numerosissimi e vivono liberi sulla superficie cutanea, per cui ne consegue una altissima contagiosità con possibilità di epidemie in ospedali, RSA o altri istituti.


Fig. 5

copia conforme all

12. Diagnosi

La diagnosi di scabbia è di competenza dermatologica e si basa sull'anamnesi (prurito prevalentemente notturno, stessa sintomatologia in più membri della famiglia, etc.) e sul riconoscimento di lesioni cutanee patognomoniche e secondarie con la caratteristica topografia.
Viene confermata dalla dimostrazione microscopica del parassita e dei suoi prodotti (feci e uova), eseguita su uno scraping cutaneo prelevato da vescicole, cunicoli o squame in caso di scabbia norvegese.
Tuttavia, la scarificazione dei cunicoli e l'osservazione al microscopio richiedono dimestichezza ed esperienza e non sono standardizzabili.
Più recentemente, la dermatoscopia ha reso la diagnosi di scabbia molto più semplice, rapida e sicura, sostituendosi nella maggior parte dei casi alla microscopia.
Nel 2020 l'International Alliance for the Control of Scabies (IACS) ha inserito la dermatoscopia tra i possibili strumenti in grado di confermare la diagnosi di scabbia, attraverso l'osservazione diretta dell'acaro (che apparirà come una piccola macchia triangolare marrone all'estremità distale di un cunicolo).
La dermatoscopia è inoltre utile nel riconoscimento dei cunicoli, permettendo di differenziarli da croste ematiche, squame e altre lesioni cutanee non specifiche di scabbia.

13. Trattamento della scabbia

L'approccio corretto ad un paziente con scabbia comprende il trattamento della persona e dei suoi contatti e la disinfestazione della biancheria personale, della biancheria letteraccia e dell'ambiente. Se queste misure non sono applicate si assisterà inevitabilmente ad una recidiva della malattia nello stesso soggetto o alla comparsa degli stessi segni e sintomi nei familiari e/o nei contatti stretti.
Per il trattamento della persona e dei familiari e contatti stretti, sono a disposizione terapie topiche a base di benzoato di benzile al 25% (in unguento semplice) e permetrina al 5% (in crema base), nonché il farmaco per uso orale Ivermectina, autorizzato da AIFA da maggio 2021, al dosaggio di 200 mcg/kg in un'unica somministrazione da ripetere dopo 7 - 14 giorni.
Ivermectina è controindicata in bambini di peso corporeo < 15 kg.
Tutti i farmaci, topici e sistemici, attualmente disponibili sono acaricidi ma non ovicidi per cui si rende necessario ripetere sempre il trattamento dopo almeno 7 giorni.
Recentemente, si sono fatti sempre più consistenti i dati riguardo ai fallimenti della terapia topica con permetrina, che rappresenta tuttora la prima linea terapeutica nel nostro Paese.
Se si stia assistendo effettivamente all'insorgenza di una vera e propria resistenza a tale farmaco o quanto meno a una "tolleranza" al trattamento è ancora dibattuto.
Il benzoato di benzile al 25% in unguento semplice da applicare per 3 sere consecutive e da ripetere per altre 2 sere dopo una pausa di 7 giorni è efficace, sicuro e ben tollerato, anche in età pediatrica.
Il preparato deve essere applicato su tutta la superficie cutanea esclusa la testa, con particolare attenzione alle mani.
Su queste ultime il preparato deve essere applicato su tutta la superficie superiore e inferiore, con particolare attenzione agli spazi interdigitali e all'iponichio.
Dopo 24 ore la medicazione viene allontanata con un bagno (doccia) caldo, bisogna spazzolare con cura sotto le unghie.
Quindi nuova medicazione.

NOTA BENE:
le unghie vanno tagliate corte, e lo spazio subungueale va spazzolato con cura, in quanto fonte importante di disseminazione dell'acaro col grattamento.
Alla fine del trattamento è necessaria una visita dermatologica di controllo per accertare la guarigione.
Il prurito può persistere per alcuni giorni, anche per l'azione irritante delle medicazioni, e le lesioni nodulari tipicamente persistono per diverse settimane.

Copia conforme all'originale

Al fine di evitare una re-infestazione e di prevenire la trasmissione della parassitosi sono indispensabili alcune misure complementari, da seguire in particolare nei casi di scabbia norvegese, nella quale il numero di acari infettanti è estremamente alto.

14. Notifica e sorveglianza sanitaria

La sorveglianza delle malattie infettive è affidata al "Sistema di notifica delle malattie infettive" (PREMAL), istituito con decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2022.
Tale decreto sostituisce la sorveglianza clinico epidemiologica e prevenzione delle malattie infettive-diffusive così come indicato dal decreto Ministero della Sanità 15 dicembre 1990 "Sistema Informativo delle Malattie Infettive e Diffusive" e dalle successive circolari ministeriali riferite alla normativa europea.
Il medico, sia ospedaliero che di medicina generale, pediatra di libera scelta o medico che svolga attività privata, ha l'obbligo di segnalare al servizio di Igiene Pubblica, competente per territorio, qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva reale o sospetta, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione.
In riferimento alla scabbia, in caso di malattia sospetta o accertata la notifica di malattia infettiva deve essere inviata entro 48 ore.
Nella notifica il medico deve indicare la malattia sospetta o accertata, gli elementi identificativi del paziente, gli accertamenti diagnostici eventualmente effettuati, la data di comparsa della malattia.
L'attivazione della competente U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione e gli interventi successivamente intrapresi sono riportati nella PST.AIPN.09 procedura Aziendale "Intervento a seguito di notifica di malattia infettiva" consultabile al seguente link:

https://areariservata.uslcentro.toscana.it/index.php/prevenzione/dipartimento-delle-prevenzione/area-igiene-pubblica-e-della-nutrizione/1599-procedure-tecnico-operative-professionali/17873-pst-aipn-09-intervento-a-seguito-di-malattia-infettiva?highlight=WyJpbmZldHRpdmUiXQ==

In seguito alla ricezione della notifica la U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione competente per territorio provvede alla effettuazione della inchiesta epidemiologica come da istruzione operativa PST.AIPN.09.IO.01, che prevede ricerca e gestione attiva dei contatti (conviventi/lavorativi/scolastici) del caso indice, attivazione della sorveglianza sanitaria e delle misure di educazione sanitaria di tutti i conviventi e degli altri contatti.
Come è noto il periodo di incubazione nel caso di una prima infezione ha una durata da due a sei settimane (mediamente tre settimane); in relazione al tempo di incubazione, si ricercano i contatti riferendosi alle sei settimane prima della insorgenza dei sintomi e si indaga sulla presenza o meno di sintomatologia per sospetta scabbia.
Nel caso in cui la sintomatologia sia presente, si rende necessario eseguire visita medica per verificare la presenza di malattia.
Viene effettuata inoltre educazione sanitaria fornendo informazioni sulla sintomatologia, sulla eventuale opportunità di eseguire profilassi farmacologica e sulle misure di sanificazione ambientale da adottare.
Nel caso di conviventi/contatti stretti è necessario che la terapia (se risultassero affetti da scabbia) o la eventuale profilassi farmacologica (indicata da specialista/MMG/PLS) vengano iniziate contemporaneamente da tutti i conviventi e che in tutti gli ambienti di vita vengano adottate idonee misure igieniche.
L'approccio corretto ad un paziente con scabbia comprende il trattamento della persona, l'eventuale profilassi dei suoi contatti e l'adozione di idonee misure di disinfestazione della biancheria personale, degli indumenti, della biancheria lettereccia ed eventualmente dell'ambiente.
Nel caso di mancata applicazione di queste misure la probabilità che si verifichi una recidiva nel paziente o la comparsa di casi di scabbia nei contatti stretti è elevata.

Copia conforme all'originale

È inoltre necessario che la persona affetta da scabbia rimanga isolata fino alla effettuazione del primo idoneo trattamento, potendo rientrare in collettività 24 ore dopo la esecuzione dello stesso.
La sorveglianza dei contatti individuati termina dopo circa sei settimane dall'inizio della sorveglianza sanitaria.
L'intervento di sorveglianza viene chiuso dopo verifica degli esiti della stessa, effettuata al termine del periodo di incubazione per escludere la presenza nei contatti di casi secondari.
L'inchiesta epidemiologica del caso indice e la sorveglianza sanitaria degli esposti nel territorio sono di competenza delle strutture di Igiene Pubblica e Nutrizione territorialmente presenti.
La profilassi viene proposta ma non prescritta né fornita.

15. Identificazione e gestione del caso sospetto di scabbia in ambito ospedaliero

La scabbia è una patologia verso la quale occorre sempre mantenere un elevato indice di sospetto, pertanto occorre identificare i pazienti da isolare già in PS.
Il paziente accede al Pronto Soccorso con sintomatologia cutanea e l'operatore sanitario del triage somministra la check list con le domande di identificazione del caso sospetto, verificando se sono presenti almeno due dei seguenti criteri:

1. presenza di prurito, che si acutizza nelle ore notturne
2. coinvolgimento di sedi tipiche (descritte precedentemente: spazi interdigitali mani e piedi, polsi, cavi ascellari, regione mammaria e glutea, genitali…)
3. presenza di stessa sintomatologia in altri membri del nucleo familiare. (**vedi Allegato 1**)

In caso di positività di almeno due dei criteri sopracitati si deve sospettare la presenza di scabbia e attivare le misure di isolamento di seguito descritte.

Collocazione del paziente:
Disporre l'isolamento in stanza singola con bagno.
Se la stanza singola non fosse disponibile realizzare l'isolamento funzionale, separando il paziente dagli altri pazienti almeno di 1 mt, applicando le precauzioni standard e da contatto.
Limitare il più possibile gli spostamenti ed i contatti del soggetto.

Misure assistenziali:
Particolare attenzione deve essere posta al contenimento della trasmissione agli operatori e all'ambiente circostante.
La trasmissione può avvenire per contatto diretto o indiretto, mediata da suppellettili, superfici ed oggetti personali, (quest'ultima con minore incidenza).
Eseguire scrupolosamente l'igiene delle mani prima e dopo la rimozione dei guanti monouso seguendo le indicazioni OMS in base alle azioni assistenziali eseguite.
Predisporre presidi monouso o dedicati per l'assistenza; in caso di svestizione del paziente non far cadere a terra gli indumenti ma inserirli in un sacco di plastica scuro da chiudere immediatamente identificandolo come infetto.

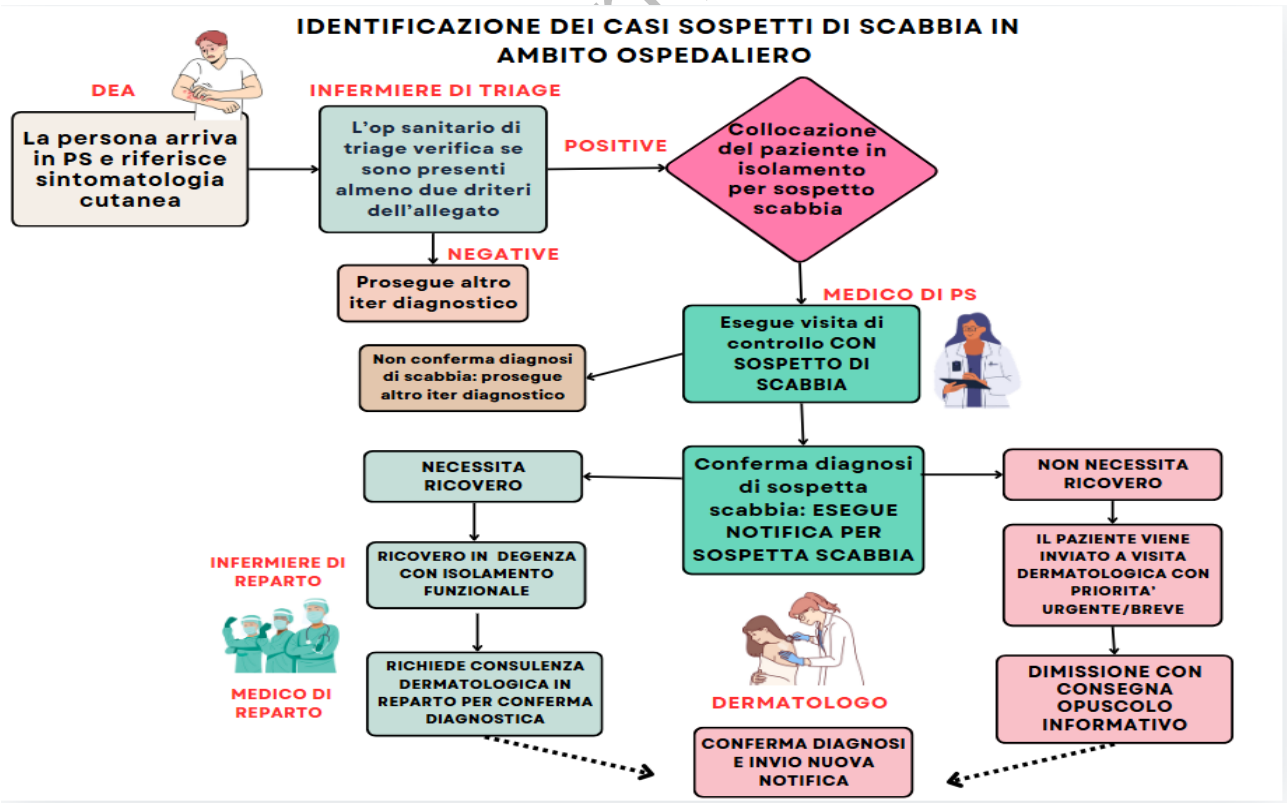
Medico di Pronto Soccorso/ Dea:
Esegue la visita e se conferma il sospetto di scabbia compila la scheda di notifica obbligatoria di malattia infettiva per sospetta scabbia, (da inviare in Direzione Sanitaria di Presidio e all'Igiene Pubblica e Nutrizione di riferimento).
Se il paziente non necessita di ricovero, viene dimesso a domicilio con consegna dell'opuscolo informativo (vedi **Allegato 3**) ed inviato a visita dermatologica con priorità urgente/breve da prenotare attraverso il CUP. La richiesta di visita urgente dovrà essere compilata dal medico di Pronto Soccorso che effettua la visita, che potrà prescrivere il trattamento.
La prenotazione può essere fatta direttamente dal PS nelle agende post - DEA al momento della dimissione del paziente da PS.
È possibile anche, nei casi di sospetta o confermata diagnosi di scabbia, l'invio ai centri Malattie Trasmissibili Sessualmente (MTS), presenti sul territorio aziendale.

Copia conforme all'originale

Se il paziente non è dimissibile, si dispone il ricovero in isolamento funzionale, con precauzioni standard e da contatto; solo per i casi di scabbia norvegese occorre disporre l'isolamento in stanza singola. In entrambi i casi la durata dell'isolamento è di 24 ore dall'inizio della terapia.

Coordinatore infermieristico DEA o suo delegato:
In via preventiva raccoglie una lista di nominativi degli operatori che hanno assistito il paziente **SENZA** adeguati **DPI** e dei degenti che hanno soggiornato vicino al paziente, dimessi successivamente a domicilio e/o ricoverati, che hanno avuto contatti potenzialmente contagianti con il paziente, da inviare rispettivamente alla Medicina Preventiva e alla Direzione Sanitaria di Presidio per gli adempimenti di legge.
La lista deve essere comprensiva dei dati anagrafici dei soggetti coinvolti e del numero di telefono per successive eventuali comunicazioni.
Il Coordinatore Infermieristico o suo delegato attiva i processi di pulizia e sanificazione, secondo quanto previsto dai protocolli in essere nei diversi Presidi Ospedalieri.

NOTA BENE:
Qualora la diagnosi venga fatta successivamente, come nel caso di un paziente la cui principale morbilità è una malattia diversa dalla scabbia (es cardiopatia, BPCO etc.) e non viene sospettata in entrata in PS per motivi di urgenza, la trasmissione dell'infestazione può avvenire nell'ambiente, ad altri pazienti ed operatori.
La necessità di stabilizzare il paziente clinicamente potrebbe inficiare l'adozione puntuale delle precauzioni standard e per via di trasmissione da parte del personale sanitario.
In caso di successiva conferma di diagnosi di scabbia, è necessario risalire ai contatti stretti avuti dal paziente da parte degli operatori sanitari per un percorso di sorveglianza stabilito dal medico competente e/o medicina preventiva.
Si riporta in flow chart il percorso del paziente dall'identificazione del caso sospetto in DEA alla conferma diagnostica dello specialista.



Copia non valida come originale

16. Gestione del paziente nei setting di degenza

Qualora sia disposto il ricovero di un paziente con scabbia, dovranno essere applicate le azioni per l'isolamento funzionale ed applicazione delle precauzioni da contatto come da procedura.
In caso di paziente con scabbia norvegese, il paziente deve restare in una stanza singola con bagno; se non fosse possibile può condividere la stanza con pazienti aventi la stessa patologia (isolamento di coorte), altrimenti occorre realizzare l'isolamento funzionale.
Durante tutte le fasi del percorso limitare le uscite del paziente dalla camera ai soli scopi essenziali; se il trasferimento è indispensabile, è necessario informare il personale della struttura presso la quale il degente viene trasferito e il personale dei trasporti interni, assicurandosi che vengano mantenute le precauzioni.
Al paziente si applica la misura dell'isolamento fino a 24 ore di distanza dall'inizio della terapia.
È auspicabile che i pazienti con scabbia accertata vengano assistiti da personale dedicato.
Le modalità di prevenzione e controllo della diffusione della scabbia in ambito ospedaliero sono descritte nell'**Allegato 2**, mentre le indicazioni per le misure di prevenzione e controllo in ambito comunitario sono descritte nell'**Allegato 3**.
Tali documenti sono distribuiti al paziente, ai famigliari e ai caregivers nell'ambito del processo di educazione sanitaria.

17. Diffusione/Conservazione/Consultazione/Archiviazione

La diffusione è a cura dalla struttura SOSD Infezioni Correlate all'Assistenza:

- L'originale è conservato presso la struttura indicata in precedenza.

La documentazione sarà visibile presso il sito istituzionale il cui percorso è:

- Intranet aziendale-Gestione documenti-Direttore Sanitario-Staff di Direzione Sanitaria - Area qualità e sicurezza delle cure - SOSD Infezioni Correlate all'Assistenza.
- La diffusione tramite invio e-mail avverrà alle strutture indicate in elenco a seguire.

18. Monitoraggio e controllo

Il monitoraggio della procedura si realizza attraverso l'indicatore di processo, relativo alla adesione alle indicazioni per la corretta notifica dei casi di sospetta scabbia:

Nr. di accessi al PS per sospetta scabbia.
1) _____

Nr. totale delle notifiche compilate in PS

Nr. di accessi in reparto per sospetta scabbia
2) _____

Nr. totale delle notifiche compilate in reparto

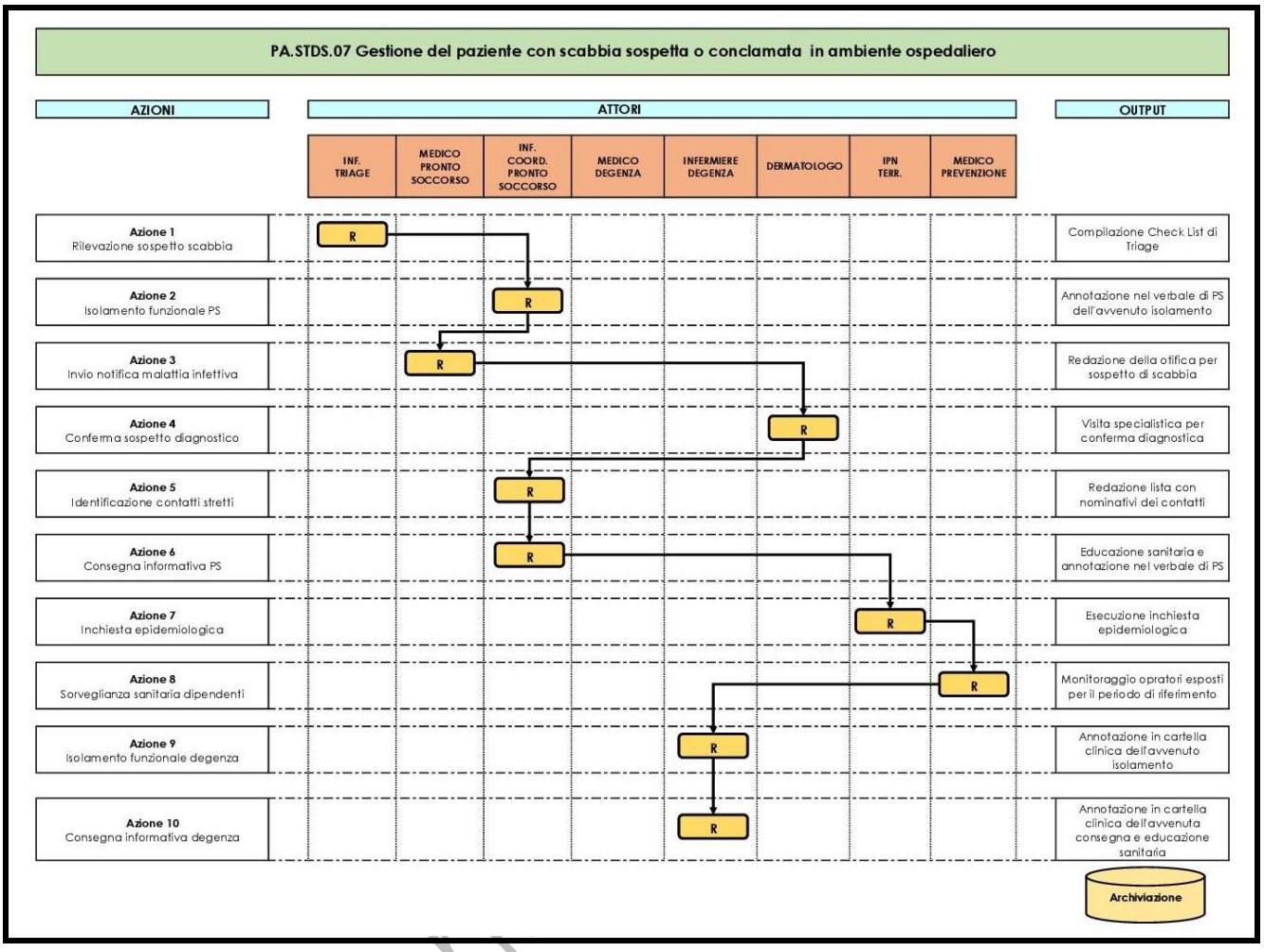
L'indicatore è calcolato con cadenza annuale da parte dei Team AID di Presidio, in collaborazione con il Dipartimento di Emergenza Urgenza e la SOSD ICA, utilizzando come fonte dati programma informatico FIRST AID.

19. Revisione

La revisione si effettua su motivazioni sostanziali, e comunque si consiglia ogni cinque anni.

Copia conforme all'originale

20. Swim lane



21. Allegati

- Allegato 1 Criteri per l'attivazione delle misure di isolamento per scabbia in Pronto Soccorso ospedaliero.
- Allegato 2 Misure di controllo per la gestione del paziente con scabbia in ambito ospedaliero.
- Allegato 3 Misure di controllo per la gestione del paziente con scabbia in comunità.

22. Indice revisioni

Revisione n°	Data emissione	Tipo modifica	Titolo
0	18/12/2024	**PRIMA EMISSIONE**	

23. Lista di diffusione

- Direttore Sanitario aziendale
- Direttore Rete Ospedaliera
- Direttore Rete Territoriale
- Dipartimento Medicina Multidimensionale
- Dipartimento di Assistenza Infermieristica ed Ostetrica
- Dipartimento delle Professioni Tecnico-Sanitarie
- Dipartimento della Prevenzione

Copia conforme all'originale